Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Pic tensionnel (poussée hypertensive)

Adulte · enfant : avis médical · traiter la personne, pas le chiffre

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · douleur thoracique ou dorsale (asymétrie de PA : dissection ?), essoufflement, signe d'AVC, confusion, céphalée brutale, convulsion, trouble de la vue ; PAS > 200 persistante et médecin injoignable.

J'applique si

- PAS **≥ 180 mmHg** et/ou PAD **≥ 110 mmHg**.
- Découverte au contrôle, ou mesure faite pour céphalée, malaise, épistaxis, agitation.

Je ne fais pas

- Donner un **antihypertenseur** sans avis médical.
- **Nifédipine sublinguale** ou capsule percée : jamais (AVC, infarctus).
- « Si besoin » antihypertenseur sans critère écrit (chiffre, délai, maximum/24 h).
- Considérer céphalée modérée, épistaxis ou acouphènes isolés comme des signes de gravité.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. **Recontrôle après 5 min de repos**, **aux deux bras**, brassard adapté ; garder le bras le plus élevé.
2. Atteinte d'organe ? Douleur thoracique, dyspnée, déficit, confusion, céphalée intense, trouble visuel → **15**.
3. Cause : **douleur**, **globe** (bladder scan), fécalome, anxiété, AINS, **traitement oublié ou arrêté**.
4. Lésion médullaire ≥ T6 : **dysréflexie** → asseoir, vider la vessie, sonde coudée, fécalome.
5. **Repos ≥ 30 min**, traiter la cause ; dose oubliée : avis avant de la donner.
6. Recontrôler à 30 min, puis **toutes les heures** tant que PA ≥ 180/110.

SUR AVIS MÉDICAL

7. Antihypertenseur prescrit (molécule, dose, voie) ; baisse **≤ 25 %** en quelques heures.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Repères

≥ 180/110 → repos, cause, recontrôle

> 200 aux deux bras après repos → avis **sans délai**

Atteinte d'organe → **15**, quel que soit le chiffre

- Après un traitement prescrit : PA toutes les 30 min pendant 2 h ; hypotension orthostatique, chute

J'appelle le médecin

- **Sans délai** : PAS > 200 mmHg aux deux bras après repos.
- **Le jour même** : PA ≥ 180/110 persistante sans urgence, récidive, oubli ou refus de traitement.

Je surveille et je trace

- PA aux deux bras, FC, conscience, céphalée ; chiffres (heure, bras), cause, avis.
- AS/AES : PA > 200 → IDE sans délai ; jamais d'antihypertenseur de leur initiative.

À retenir : Sans atteinte d'organe, aucune urgence à baisser la PA : une baisse brutale est plus dangereuse que le pic.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ESC/ESH 2018 (HTA de grade 3, urgences hypertensives), repris par le CEMIR, Médecine intensive-réanimation, chap. 16 HTA de l'adulte ; PHNVB, Gestion d'une poussée hypertensive chez l'adulte (MAJ 10/2025) ; OMéDIT CVL, dotations (02/2025) ; ARS IDF/SGGIF fiche 0 (2016).

Réf. DOTR-IDE-HTA | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature